

07 - 07- Les Délires Chroniques Non Dissociatifs - Pr. ADALI

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous rencontrer encore une fois pour traiter ce cours sur les délires chroniques non dissociatifs. Les objectifs du cours sont analyser à propos des délirants, reconnaître les éthologies d'un délire chronique, différencier une schizophrénie et délire chronique, argumenter l'hospitalisation d'un délirant chronique, évaluer la dangerosité d'un délire chronique et expliquer les principes de traitement. La nomenclature française traditionnelle distingue plusieurs types de délires chroniques non schizophréniques ou non dissociatifs, dont la classification est fondée sur le mécanisme prévalant du délire.

Les délires chroniques non dissociatifs ont des caractéristiques communes. Évolution chronique, plus de 6 mois, l'absence de détérioration intellectuelle, l'absence de dissociation de la pensée, l'absence de signes déficitaires. Les délires chroniques non dissociatifs sont très peu sensibles au traitement neuroleptique, ayant un risque majeur de passage à l'acte auto ou hétéroagressif, avec un maintien d'un bon fonctionnement sans traitement.

Les délires chroniques non dissociatifs sont des délires systématisés, c'est-à-dire ordonnés, compréhensibles et logiques, pouvant entraîner l'adhésion d'autres hommes, avec une thématique souvent unique. Un délire avec un mécanisme prépondérant caractérisant chaque délire chronique. L'interprétation caractérise les délires paranoïaques, l'hallucination caractérise la psychose hallucinatoire chronique, et l'imagination caractérise la paraphrénie.

Selon le DSM-5, les délires chroniques se définissent selon leurs thèmes principaux erotomane, jalousie, sointique, persécution ou mégalomane. La psychose hallucinatoire chronique est exclue de cette catégorie diagnostique. Un délire est caractérisé par son ancienneté, aiguë ou chronique, moins ou plus de 6 mois, son mécanisme, intuitif, imaginatif, hallucinatoire, sa thématique simple ou polythématique, sa structure systématisée ou non, l'adhésion partielle ou totale, la participation émotionnelle, c'est-à-dire le vécu émotionnel du délire, l'extension en secteur où un seul domaine de la vie est atteint, par exemple le domaine professionnel, ou l'extension en réseau où plusieurs domaines de la vie sont atteints, le domaine professionnel, social et autres.

On va aborder maintenant le chapitre des délires paranoïaques, composé de délires passionnels, délires d'interprétation systématisé et délires sensitifs de relation. Les délires passionnels ont des caractéristiques générales communes. Les thèmes sont les grands thèmes de passion humaine, revendication, jalousie, erotomanie, idéologie et autres.

Ils ont un mécanisme unique, interprétatif. Le début est brutal par une interprétation ou une intuition délirante qui s'est enrichie secondairement de nombreuses interprétations avec une participation émotionnelle forte. Le délire erotomane se voit le plus souvent chez une femme de 40 à 55 ans, célibataire, convaincue qu'une personne célèbre ou inaccessible est amoureuse d'elle.

Elle croit que c'est cette personne qui l'a aimée en premier. Elle pense que l'amoureux supposé est incapable de lui révéler son amour, qu'il est contraint de le lui cacher et d'agir de manière contradictoire, mais qu'il lui fait passer des messages implicites. C'est typiquement l'interprétation.

Le délire erotomaniaque évolue en trois phases. La phase d'espoir et attente avec poursuite de la personne aimée. La phase de dépit avec possibilité de tentative de suicide.

Et enfin, la phase de rancune caractérisée par un passage à l'acte hétéroagressif fréquent contre la personne aimée. Le délire de jalousie touche plus les hommes que les femmes. Le début est ainsi dur, par une conviction de l'infidélité du conjoint.

Le patient surveille son conjoint, enquête sur lui, cherche des preuves, avec risque d'agression physique, d'homicide ou de suicide lorsque le conjoint le quitte. S'associe régulièrement à un alcoolisme chronique qui pourrait être un facteur déclenchant et ou aggravant. Le délire de revendication correspond à la conviction d'un préjudice subi.

Le patient s'engage dans plusieurs plaintes et procès. L'hypochondrie délirante est une revendication d'une faute médicale. Les délires quérulons et processifs correspondent à la demande de réparation judiciaire d'un grief léger, réel ou non.

Le patient effectue plusieurs plaintes et revendications à l'égard des autorités, dans la forme quérulante, ou entreprend une succession d'actions judiciaires dans la forme processive. Les inventeurs méconnus revendiquent des découvertes mineures, inutiles ou fausses. Les idéalistes passionnés revendiquent une idéologie politique, religieuse, philosophique ou scientifique.

Quant à la sinistrose, elle correspond à la revendication d'un préjudice corporel après un traumatisme. Après les délires passionnels, on passe maintenant au délire d'interprétation systématisée. Qui se développe le plus souvent chez des patients présentant une personnalité pathologique de type paranoïaque.

Le début peut être brutal, après un facteur déclenchant, ou insidieux le plus souvent. Par une élaboration délirante d'abord, on me regarde, on parle de moi, ce n'est pas comme d'habitude. Puis des interprétations délirantes secondairement organisées en un système cohérent.

En effet, dans les délires d'interprétation systématisée, tous les événements rencontrés seront rattachés au système délirant. Il n'y a plus de hasard dans la vie du patient. Les thèmes sont la persécution portant sur les biens, la santé, voire la vie, la mécanomanie, on m'en veut car je suis important, filiation, rôle politique ou mission.

La thématique délirante cohérente peut entraîner l'adhésion d'autrui. Le délire d'interprétation systématisé est structuré par nos réseaux. Le patient se considère au centre d'un vaste complot, envahissant tous les champs d'activité du patient, avec possibilité de passage à l'acte médico-

légaux contre les persécuteurs présumés.

Dans les délires sensitifs de relations de Kretschmer, il y a la personnalité prémorbide de type sensitive, caractérisé par l'hypersensibilité dans les relations avec les autres, la vulnérabilité et la tendance à intérioriser les échecs relationnels et affectifs, la faible confiance en soi et un repli sur soi. Les événements déclenchants peuvent être les échecs répétitifs, les conflits, les humiliations ou les événements de vie pénibles et frustrations. Dans les délires sensitifs de relations, les thèmes sont la persécution, humiliation, impression d'hostilité, d'allusion péjorative, les idées de référence, on parle de moi, on se moque de moi, la culpabilité, le patient mérite cette hostilité car il a commis des fautes.

Cependant, à la différence des délires passionnels, il n'y a pas de revendication, mais plutôt une résignation passive. Dans le délire sensitif de relations, la participation affective est forte, avec tonalité dépressive, sentiment d'échec, de honte, d'infériorité, de culpabilité, d'anxiété. L'organisation du délire se fait en secteur concernant le cercle relationnel proche du sujet, familial ou professionnel.

Maintenant, on passe au chapitre de la psychose hallucinatoire chronique. La psychose hallucinatoire chronique est à prédominance féminine, c'est-à-dire surtout chez les femmes célibataires, débutant tardivement entre 30 et 40 ans. Le mode de début est classiquement brutal ou insidieux et progressif.

Dans la phase d'état, les thèmes délirants sont la persécution, la possession, des thèmes sexuels et d'influence. Le mécanisme délirant dans la psychose hallucinatoire chronique est de type hallucinatoire. Hallucination auditive, sous forme de voix menaçante ou insultante, des bruits.

Hallucination olfactive, odeur de gaz, d'excréments. Hallucination gustative, faisant suspecter l'empoisonnement. Des hallucinations célestésiques concernant la sphère génitale ou des contacts cutanés.

L'automatisme mental est constant, à type de devinement de la pensée, vol de la pensée, écho de la pensée, commentaire des actes pour pensée imposée avec sa norme d'influence. La participation émotionnelle dans la psychose hallucinatoire chronique est forte, à tonalité onctueuse ou dépressive. La conviction délirante est forte avec des réactions pathologiques, dialogue avec les voix, attitude d'écoute, moyens de défense contre les hallucinations et autres.

Maintenant on passe au chapitre de la paraphrénie. La paraphrénie est rare, elle débute entre 30 et 45 ans. Le mode de début est insidieux le plus souvent.

Dans la phase d'état, les thèmes du délire sont fantastiques, sous forme d'univers surréalistes, sans référence connue d'espace et de temps, d'émotions cosmiques, spirituelles ou mythologiques. Les thématiques délirantes peuvent être aussi mégalomaniaques. Le passant est

la figure centrale du délire.

Il a un rôle à accomplir, il est victime de persécution par magie, envoûtement et empoisonnement. Je vous demande de bien chercher dans la littérature le nom d'une paraphrène très très célèbre. Il s'agit d'un délire riche dans la paraphrénie, incohérent, en secteur, avec une participation affective intense, avec exaltation de l'humeur, une bonne adaptation du passant à la réalité extérieure, avec juxtaposition du monde délirant et du monde réel.

C'est ce qui explique la richesse de la littérature, de notre paraphrène connu. Les diagnostics différentiels du délire paranoïaque sont les troubles liés à l'usage de substances, l'accès psychologique aiguë, la manie et les idéologies organiques. Les diagnostics différentiels de la psychose hallucinatoire chronique sont les schizophrénies.

Quant aux paraphrénies, leurs diagnostics différentiels sont la schizophrénie, les étiologies organiques et le syndrome démentiel. Dans l'éthiopathogénie des délires chroniques non dissociatifs, il y a l'implication de plusieurs facteurs. Les facteurs génétiques, les traits de personnalité, les facteurs de stress psychosociaux.

Les conditions environnementales favorisantes sont l'isolement social, le célibat et autres. Deux mécanismes de défense sont constamment mis en évidence pour expliquer l'éthiopathogénie des délires chroniques non dissociatifs, la projection et la dénégation. La psychose hallucinatoire chronique évolue par poussée.

Sous traitement neurolégitime, il y a ce qu'on appelle un enquistement du délire. Il devient non envahissant, critiqué partiellement, avec conservation du jugement, de la vie affective, sociale et relationnelle. La comorbidité avec la dépression se fait dans 10 à 25 % des cas.

Le pronostic est généralement assez bon. Quant à la paraphrénie, elle évolue par poussée. Alternance entre période aiguë et période d'atténuation.

Le délire est fixe. L'adaptation à la réalité est souvent longtemps conservée, avec évolution possible sur un mode schizophrénique, selon certains auteurs. Concernant les délires paranoïaques, le retentissement socioprofessionnel est variable.

L'évolution se fait par poussée-rémission, de quelques mois à quelques années, partiellement ou pas. Avec possibilité d'épisodes dépressifs, avec risque de passage à l'acte auto-agressif. Des conduites pathologiques sont notées, notamment les actes médico-légaux, les conduites addictives, les fuites, avec claustration, refus alimentaire, démarches procédurières, etc.

On note souvent l'atténuation des symptômes avec l'âge. Il n'y a pas de traitement bien codifié pour les délires chroniques non dissociatifs. Le traitement repose principalement sur les antipsychotiques et l'instauration d'un cadre thérapeutique visant à préserver l'insertion sociale de ces patients et à éviter les complications médico-légales.

Dans la psychose anéphyloire chronique, l'hospitalisation est souvent nécessaire pour poser le diagnostic, faire un bilan d'organicité, et les indiquer aussi s'il y a un trouble de comportement ou s'il y a un risque médico-légal. On traite par les neuroleptiques atypiques qui sont à action antipsychotique, c'est-à-dire anti-délire, et par les antidépresseurs s'il y a une dépression associée. La psychothérapie de soutien est au jour de nous.

Dans la prise en charge de la paranoïa, les antipsychotiques sont efficaces sur les hallucinations, l'excitation psychomotrice et les angoisses, mais ils sont très peu efficaces sur les idées délirantes. L'accomplissement du traitement est très difficile, d'où la nécessité de mesures institutionnelles et sociales. Devant un délire paranoïaque, l'attitude du médecin doit être neutre, avec une distance adaptée pour ne pas entrer dans le mode délirant du patient, et écoute attentive, sans critique directe.

L'hospitalisation au milieu psychiatrique est nécessaire s'il y a un risque hétéro-agressif ou s'il y a une dépression secondaire. Les neuroleptiques atypiques sont très peu actifs sur les interprétations délirantes, mais ils atténuent la conviction délirante, l'angoisse et l'agressivité. Le traitement antidépresseur est systématique si les délires de relation sont desensitifs.

En conclusion, les délires chroniques non dissociatifs peuvent être longtemps cachés par le sujet, et ne se révéler qu'à l'occasion d'une phase d'exaltation passionnelle ou d'un acte délirant. L'évolution se fait par poussées à rémission. Les délires chroniques non dissociatifs sont très peu sensibles aux traitements neuroleptiques.

Je vous remercie.